

Chapitre 10 : Dissection et ulcère pénétrant de l'aorte

10.1. Dissection de l'aorte

a) Introduction :

- Définition : déchirure et clivage longitudinal de la paroi aortique, le plus souvent entre la partie externe de la média et l'adventice, aboutissant à la constitution d'un deuxième chenal à paroi fine (« fausse lumière »)
- On parle de dissection aiguë lorsque le diagnostic est posé endéans les 14 jours du début des symptômes. Lorsque le début des symptômes remonte à plus de 14 jours ou en l'absence de symptôme (par exemple découverte fortuite par une tomodensitométrie thoracique), on parle de dissection chronique.
- **On distingue :**
 - Type A : dissection intéressant l'aorte ascendante, quelle que soit l'extension
 - Type B : toutes les autres dissections
- Les principaux facteurs prédisposants sont :
 - Sexe (hommes/femmes : 5/1)
 - Âge : pic d'incidence Type A : 50-60 ans, Type B: 60-70 ans
 - Hypertension artérielle
 - Maladies du tissu conjonctif : Marfan, Ehlers-Danlos...
 - Anomalies valvulaires aortiques congénitales (bicuspidie aortique)
 - Fin de la grossesse
 - Traumatisme thoracique fermé
 - Canulation aortique
 - Consommation de cocaïne, exercice isométrique intense

b) Physiopathologie et étiologies :

- Pathogénie :
 - Déchirure due le plus souvent à une poussée d'hypertension artérielle
 - Clivage longitudinal favorisé par une maladie aortique de la média (maladies héréditaires du tissu élastique, dégénérescence physiologique, athérosclérose)
 - Extension de la dissection vers l'aval ou l'amont (dissection rétrograde)
 - Variabilité des flux à travers le "vrai" et le "faux" chenal.
- Evolution naturelle : les complications qui peuvent être observées sont
 - À la phase aiguë :
 - Insuffisance valvulaire aortique
 - Thrombose ou hypoperfusion des branches de l'aorte conduisant à une ischémie myocardique, viscérale ou de membre
 - Rupture de l'adventice

- À la phase chronique :
- Évolution anévrismale

c) Présentation clinique :

- Douleur thoracique :
 - Intensité extrême, d'emblée maximale et spontanée
 - Son siège est d'abord thoracique haut, puis secondairement migrant : douleur dorsale ou lombaire, abdominale
- Dyspnée soudaine (insuffisance valvulaire aortique)
- Examen clinique :
 - Hypertension artérielle
 - Souffle diastolique d'insuffisance aortique
 - Asymétrie des pouls
- Autres présentations cliniques :
 - Hémithorax gauche, tamponnade, hémopéritoine, choc
 - Signes d'ischémie
 - Accident vasculaire cérébral
 - Infarctus myocardique
 - Ischémie mésentérique
 - Ischémie aiguë d'un membre
 - Paraplégie

d) Pronostic :

- Dissection type A : mortalité 25 % (55 % en absence de traitement chirurgical).
- Dissection type B : mortalité 10 % dans le premier mois
- Complication tardive : dilatation anévrismale

e) Examens complémentaires :

ils confirment le diagnostic et permettent de guider la stratégie thérapeutique

- ECG : diagnostic différentiel douleur thoracique
- Rx thorax : élargissement de la silhouette aortique
- Echographie externe/transoesophagienne et tomodensitométrie (CT) avec injection de contraste :
 - Visualisation « vraie » et « fausse » lumière
- Aorto-artériographie conventionnelle :
 - Examen invasif uniquement demandé dans le cadre d'un bilan préopératoire (traitement endoluminal)
- Imagerie par résonance magnétique nucléaire (R.M.N) : contraste spontané entre le « vrai » et le « faux » chenal
- Echographie trans-oesophagienne permet de visualiser :

- « Voile intimal »
- Insuffisance aortique
- Épanchement péricardique

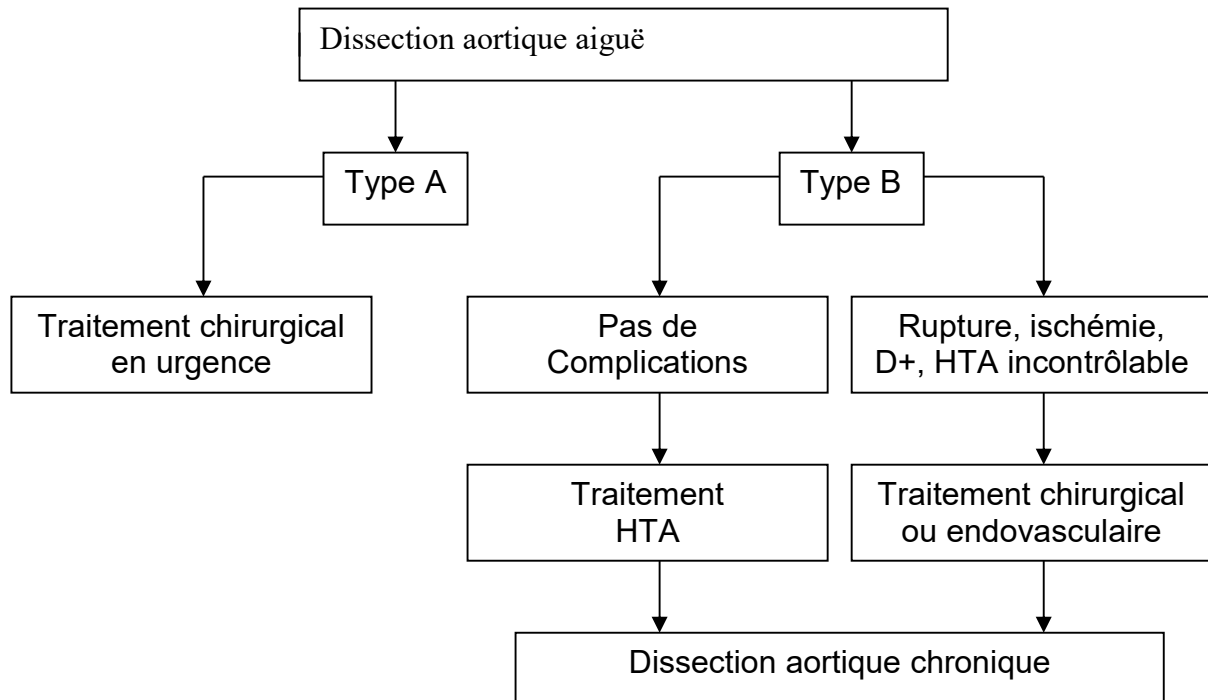
f) Traitement

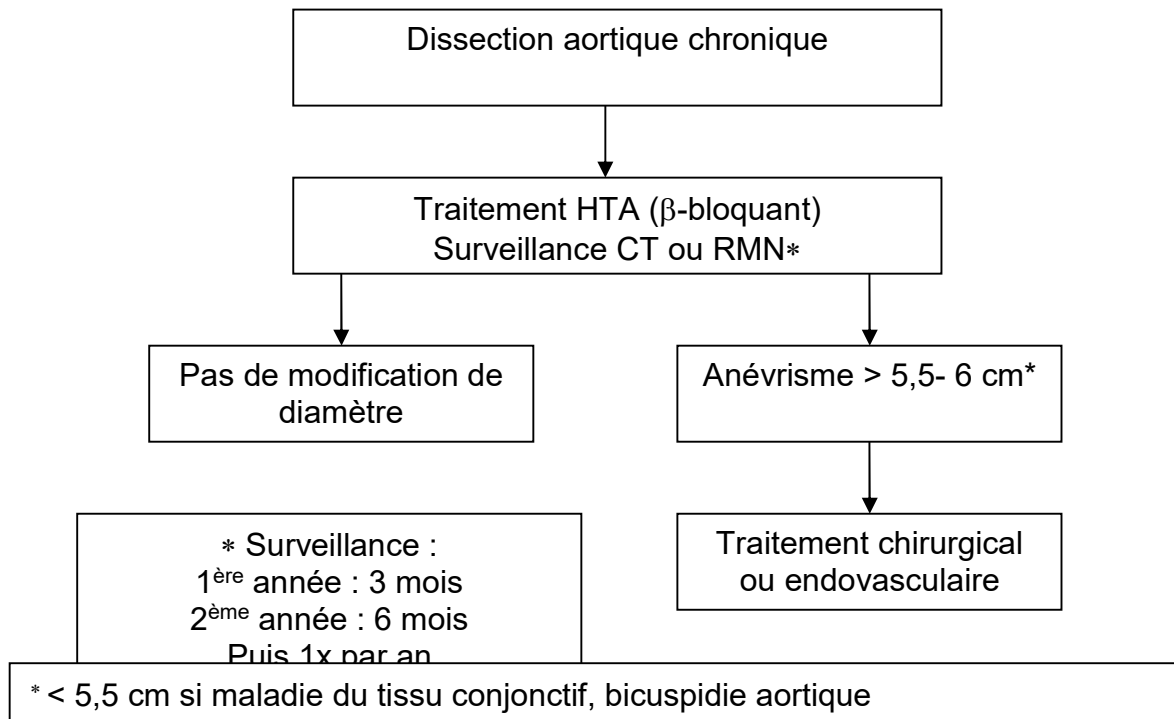
1) Traitement médical

- Surveillance U.S.I
- Traitement hypotenseur (β -bloquant) i.v.
Objectif : T.A systolique. < 120 mm Hg, T.A moyenne 80 mm Hg
- Traitement de la douleur

2) Traitement chirurgical et endovasculaire

- Indications de traitement :
 - Toute dissection de type A aigu = grande urgence chirurgicale
Méthode : Remplacement de l'aorte ascendante associé, si nécessaire, au traitement de l'insuffisance valvulaire aortique et coronarienne, etc...
 - Type B aigu en cas d'ischémie (mésentérique, membre)
Méthode : traitement endovasculaire : fenestration (création d'une communication entre vrai et faux chenal) ou revascularisation chirurgicale par pontage. Mise en place d'une endoprothèse couverte pour fermer la brèche intinale
 - Dissection aortique chronique : traitement en cas de dilatation anévrysmale
 - De l'aorte ascendante dont le diamètre ≥ 55 mm,
 - De l'aorte thoracique descendante ou de l'aorte abdominale dont le diamètre ≥ 60 mm
 - Décision d'intervention au cas par cas pour diamètre plus petit si maladie du tissu conjonctif (Marfan, Ehlers-Danlos) ou anomalies valvulaires aortiques congénitales

Traitement de la dissection aortique aiguë : algorithme décisionnel

Traitement de la dissection aortique chronique : algorithme décisionnel**10.2. Ulcère pénétrant de l'aorte***a) Physiopathologie :*

- Ulcère au niveau d'une plaque athéromateuse de l'aorte thoracique
- Rupture de la limitante élastique interne, extension de l'ulcère dans la média et au-delà → hématome de paroi, faux-anévrisme, hémomédiastin, hémothorax

b) Présentation clinique :

- Patient âgé, athéromateux
 - Douleur thoracique

c) Examens complémentaires :

Tomodensitométrie avec contraste ou R.M.N : cratère ulcéreux

d) Traitement :

Aorte ascendante : traitement chirurgical

Aorte descendante :

- Traitement médical
- Traitement chirurgical si douleur persistante, instabilité hémodynamique, expansion de l'hémothorax